Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» 194354 С-Петербург, Учебный пер., д. 5

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ № МК 107574-26-С 16.10.2026 10:24 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЖИВОТА С ВНУТРИВЕННЫМ БОЛЮСНЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Информация об оборудовании:
Название устройства: Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Aera
Инвентарный номер: 1378420
Серийный номер: 142522
Модель: MAGNETOM Aera

Описание исследования
Дата проведения исследования: 16.10.2026 09:00
Цель исследования: состояние панкреатобилиарной системы? холедохолитиаз? у пациента с диспепсией ЖКБ, холецистэктомия в анамнезе

Описание результатов
На серии МР-томограмм органов брюшной полости, выполненных в стандартных проекциях (Т1, Т2ВИ, fatsat, vibe, ДВИ) и МРХПГ – печень в размерах не увеличена, ККР правой доли - 134мм. Левая доля 73мм. Контуры печени четкие и ровные, структура однородная. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Воротная вена 12мм.
Желчный пузырь удален. Культя пузырного протока длиной 16мм, шириной до 2-3мм. Холедох до 6,5мм, без дефектов наполнения.
Поджелудочная железа размерами: головка 29мм, тело 20мм, хвост 17мм. Вирсунгов проток визуализируется на всем протяжении, шириной до 1мм. Контуры железы четкие, дольчатость сохранена, структура диффузно неоднородная за счет наличия участков жировой дегенерации. Парапанкреатическая клетчатка не изменена.
На ДВИ участков измененного МР-сигнала с признаками рестрикции диффузии не выявлено.
Селезенка обычной формы и расположения, однородной структуры, размерами до 116х70х46мм (индекс 373).
Свободной жидкости и гиперплазированных лимфатических узлов в зоне исследования не визуализируется.

Заключение
Состояние после ранее перенесенной холецистэктомии. Диффузные изменения поджелудочной железы.

Заведующий отделением /_____ / КАРЕЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

16.10.2026 10:25 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ

Информация об оборудовании:
Название устройства: Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Aera
Инвентарный номер: 1378420

Серийный номер: 142522
Модель: MAGNETOM Aera

Описание исследования
Дата проведения исследования: 16.10.2026 09:00
Цель исследования: состояние панкреатобилиарной системы? холедохолитиаз? у пациента с диспепсией ЖКБ, холецистэктомия в анамнезе

Описание результатов
На серии МР-томограмм органов брюшной полости, выполненных в стандартных проекциях (Т1, Т2ВИ, fatsat, vibe, ДВИ) и МРХПГ – печень в размерах не увеличена, ККР правой доли - 134мм. Левая доля 73мм. Контуры печени четкие и ровные, структура однородная. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Воротная вена 12мм.
Желчный пузырь удален. Культя пузырного протока длиной 16мм, шириной до 2-3мм. Холедох до 6,5мм, без дефектов наполнения.
Поджелудочная железа размерами: головка 29мм, тело 20мм, хвост 17мм. Вирсунгов проток визуализируется на всем протяжении, шириной до 1мм. Контуры железы четкие, дольчатость сохранена, структура диффузно неоднородная за счет наличия участков жировой дегенерации. Парапанкреатическая клетчатка не изменена.
На ДВИ участков измененного МР-сигнала с признаками рестрикции диффузии не выявлено.
Селезенка обычной формы и расположения, однородной структуры, размерами до 116х70х46мм (индекс 373).
Свободной жидкости и гиперплазированных лимфатических узлов в зоне исследования не визуализируется.

Заключение
Состояние после ранее перенесенной холецистэктомии. Диффузные изменения поджелудочной железы.

Заведующий отделением /_____ / КАРЕЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ , № МК 107574-26-С
12.05.1963 , муж

23.10.2026 11:17 ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Описание
Пищевод проходим, в шейном отделе пределяется очаг желудочной гетеротопии до 0,5см. Слизистая оболочка пищевода рыхлая,розовая, стенки эластичные, вены не расширены. Кардиальный жом смыкается не плотно на 40см от резцов , Z-линия на 1,0 см выше уровня кардии. Наблюдается заброс желчи из желудка в просвет пищевода.
Желудок обычной формы, в просвете пенистая желчь в большом количестве . Слизистая оболочка тела желудка отечная, гиперемированная. Складки эластичные, хорошо расправляются воздухом. При осмотре на инверсии угол Гиса сглажен, кардиальный жом смыкается не плотно. Перистальтика хорошо прослеживается. Слизистая оболочка антрального отдела желудка отечная, гиперемированная. Привратник смыкается не плотно, наблюдается рефлюкс желчи.
Луковица ДПК обычной формы, слизистая оболочка темно-розовая, рыхлая , бархатистая.
В постбульбарном отделе слизистая оболочка темно-розовая,рыхлая,бархатистая , в просвете пенистая желчь в большом количестве . Зона БДС визуально не изменена.
;

Заключение
Inlet patch шейного отдела пищевода. Рефлюкс-эзофагит. Эндоскопические признаки грыжи ПОД.Катаральный гастродуоденит. Дуодено-гастральный рефлюкс. ;